





Contexte du Pays : sur fond de stabilité, trois crises humanitaires et des investissements

sociaux à la peine

La République du Cameroun est située au cœur de l'Afrique centrale s'étendant du golfe de Guinée et de la forêt équatoriale aux confins du Sahel, jusqu'au lac Tchad. Vu la diversité culturelle et les multiples zones climatiques regroupant tous les climats d'Afrique, on l'appelle aussi « l'Afrique en Miniature ». Sa population est estimée à 29,9 millions d'habitants¹ en 2025 avec une prépondérance démographique en milieu urbain (59,4%) par rapport au milieu rural (40,5%). Elle compte un peu plus de 14,6 millions d'enfants, représentant près de la moitié de la population (49%). Les moins de 5 ans quant à eux représentent 17% de la population. Avec une moyenne de 4,8 enfants par femme, la population devrait approcher 34 millions d'habitants à l'horizon 2030, dont 17 millions d'enfants.

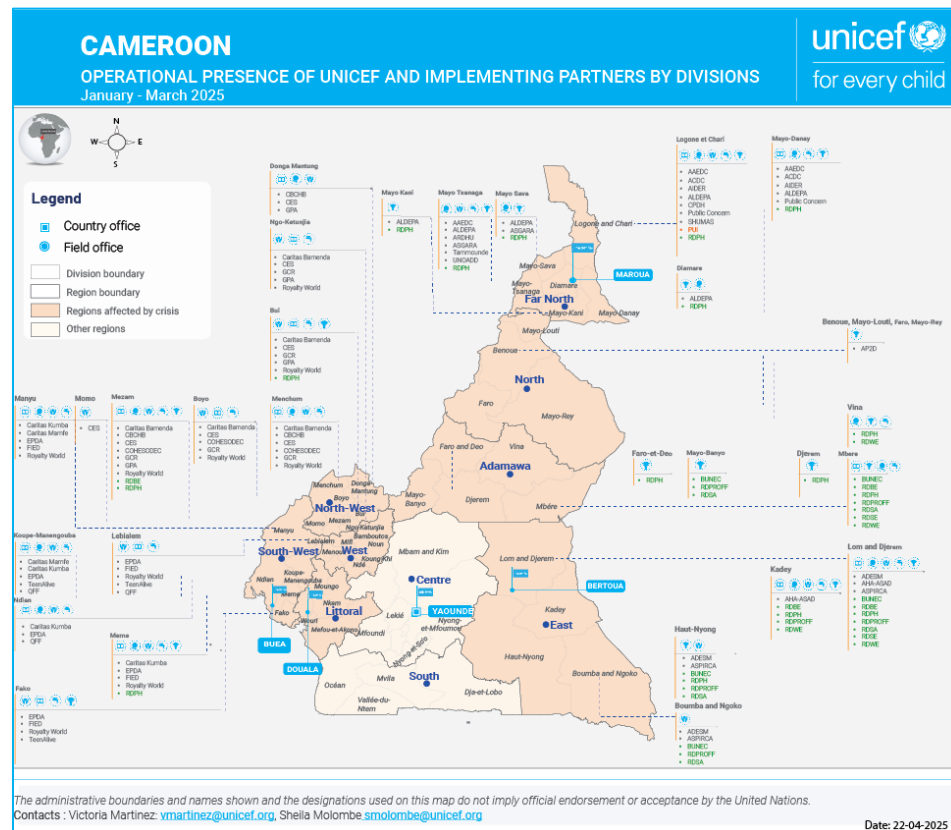
Le Cameroun jouit d'une stabilité politique depuis son indépendance, mais est affecté par des tensions internes et régionales depuis plus d'une décennie qui provoquent trois crises humanitaires (crise dans les régions d'expression anglaise, incursions et actions de groupes armés non étatiques dans la région du bassin du lac Tchad et crise des mouvements de population issue de la Centrafrique). Ces troubles, qui affectent 9 régions sur 10, ne permettent pas la continuité des services et affectent les enfants, mettant en péril leur survie, et leur état psychosocial.

Les enfants sont parmi les populations les plus touchées par les crises humanitaires. En 2025, 3,3 millions de personnes, dont 1,7 million d'enfants et 495 000 personnes handicapées, ont besoin d'une aide humanitaire². Plus d'un million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et 118 479 personnes ont quitté leur foyer au Cameroun pour traverser la frontière avec le Nigeria³.

¹ Projections BUCREP, 2020.

² Aperçu des Besoins Humanitaires 2025.

³ En mai 2025 – HCR 2025



En 2025, plus d'un million d'enfants sont ciblés pour une assistance humanitaire par l'UNICEF⁴.

Le Cameroun est richement doté en ressources naturelles (pétrole et gaz, minerais et bois précieux) et agricoles (café, coton, cacao, maïs et manioc). L'économie du pays est très diversifiée, sur le plan agricole, dans l'exploitation des ressources naturelles, de l'industrie et des services.

Avec un revenu par tête de 1 706 \$⁵, le Cameroun est considéré comme un pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure. Un pays dont l'économie se consolide par la diversité des secteurs de production et par une croissance du

⁴ HAC 2025

⁵ Data World Bank

PIB (3,2%)⁶, supérieure à la croissance démographique (2,3%) générant des ressources potentielles pour le développement, ainsi qu'une levée fiscale (13,6% du PIB) pouvant permettre d'investir dans des politiques sociales impactant le capital humain. Mais **les allocations budgétaires consacrées au social sont encore trop faibles**. En termes de secteur social, des efforts restent à faire pour atteindre les standards internationaux. Les allocations en faveur des autres services sociaux et la protection sociale représentent environ 1,7% du budget.

La part de budget allouée à l'Education stagne autour de 14%, donc en deçà des objectifs de l'Union Africaine (20%). De même, la part de budget consacrée à la Santé (4,1%) est loin des 15% des engagements pris à Abuja.

L'atteinte des ODD restera difficile dans ces conditions : quarante cinq (45) indicateurs des objectifs de développement durable (ODD) à atteindre en 2030 concernent les enfants, et parmi ceux-ci, 04 nécessitent un effort moyen, 20 un très grand effort et 08 un effort considérable.

La pauvreté des enfants augmente à bas bruit

La pauvreté monétaire ne connaît pas d'évolution positive depuis une décennie (2014-2022). Elle touche 37,7% de ménages⁷ en 2022, contre 37,5% en 2014⁷. Une augmentation du taux est observée en milieu urbain où elle a plus que doublé entre 2014 et 2022, passant de 8,5% à 21,6%⁸. Douala et Yaoundé gardent tout de même des seuils en deçà de 11%. L'incidence de la pauvreté en milieu rural reste aussi très élevée (56,3%) en 2022. Une forte disparité entre les régions caractérise le pays, avec des régions Centre, Sud, Sud-Ouest et Littoral présentant une incidence de moins de 25% et trois régions dépassant les 50% : Extrême Nord (69,2%) ; Nord (61,1%) ; Nord-Ouest (66,8%)⁹.

La pauvreté monétaire des enfants, quant à elle, est passée de 44,2% en 2014 à 45% en 2022, soit près d'un point d'augmentation (INS, 2022). Ce qui illustre la dégradation de la vie pour les enfants avec les seuils les plus élevés dans les régions du Nord-Ouest (74.1%), de l'Extrême-Nord (73,9%), du Nord (65,6%), de l'Est (49,3%) et de l'Adamaoua (49,1%) (*lire pages 11 à 13*).

Au-delà des indicateurs monétaires, ceux du développement du capital humain ne suivent pas davantage. Le Cameroun a un indice de capital humain (HCI) de 0,410, ce qui signifie **qu'un enfant né au Cameroun aujourd'hui sera 59 % moins productif à l'âge adulte que s'il avait bénéficié d'une éducation complète et d'une bonne santé**. Si ce score est inférieur aux moyennes de l'Afrique subsaharienne, les moyennes nationales masquent des inégalités substantielles: le Cameroun présente l'un des plus grands écarts en matière d'indice HCI entre les quintiles les plus riches et les plus pauvres de sa population. De plus, une grande partie de la population souffre de privations



⁶ INS 2023

⁷ ECAM 2023

⁸ ECAM 2023

⁹ ECAM 2023

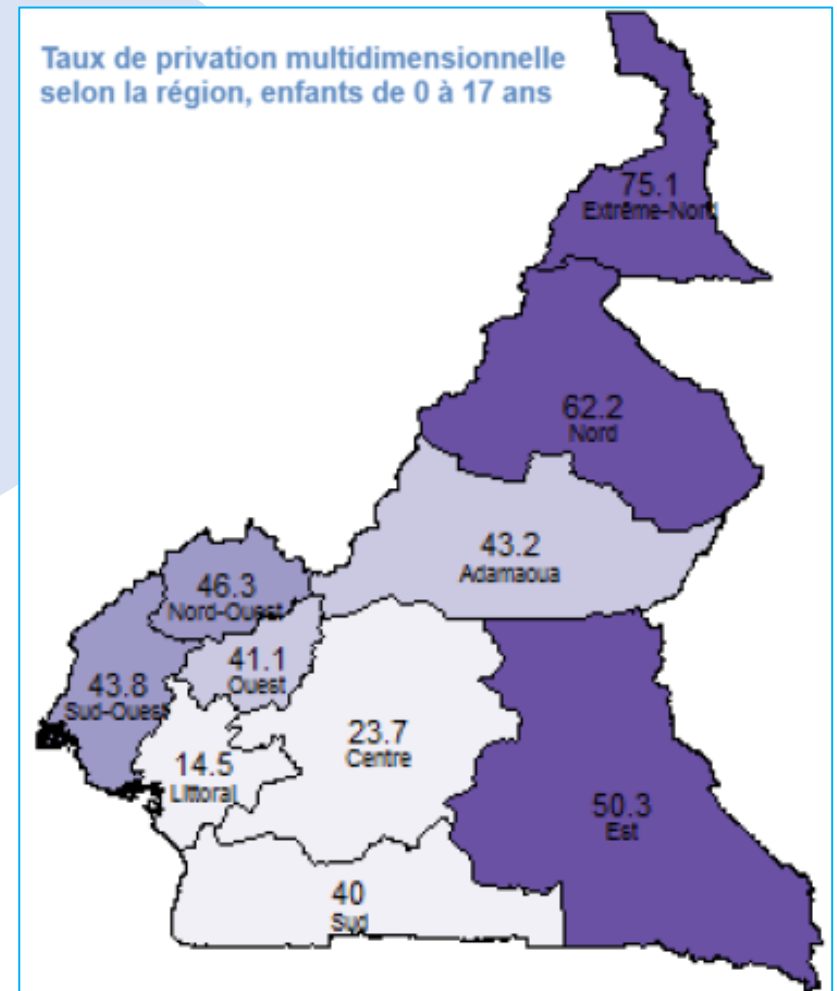
¹⁰ Banque Mondiale 2020

multiples, en particulier les enfants. En effet, **47,5% des enfants âgés de 0 à 17 ans souffrent d'au moins quatre des douze dimensions de privations** (Alimentation, Santé, Protection, Logement, Accès à l'eau, etc.) mettant en péril leur développement futur¹¹. 27,3% des enfants des milieux ruraux connaissent des privations sévères¹² contre seulement 3,0% pour les enfants des milieux urbains¹³.

L'adolescence est une période de changements importants pour les enfants, et nombreux sont ceux qui ne vivent pas dans de bonnes conditions pour effectuer cette transition physique et psychologique complexe pour passer à l'âge adulte, car **33,0% des 12 à 17 ans subissent de multiples privations**¹⁴.

Ainsi, **près de 6 millions d'enfants ne voient pas leur droits garantis pleinement**, bien que le Cameroun ait ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE) en janvier 1993, puis la Charte Africaine des Droits et du bien-être de l'enfant en septembre 1997.

Les privations et les différentes inégalités touchent particulièrement les filles et les femmes. En 2020, l'Indice de développement humain des femmes (0,53) restait plus faible que celui des hommes (0,57). Ces différences sont notamment marquées au niveau de l'éducation, mais également au niveau du revenu par habitant et avec une plus forte représentation des femmes dans le marché du travail informel.



¹¹ MODA 2017

¹² Affectés par toutes les privations

¹³ Enfants privés dans 6 dimensions ou plus, MODA 2017.

¹⁴ MODA 2014



Lutter pour survivre dans les premières années de vie



Le Cameroun compte 4,2 millions d'enfants de moins de 5 ans. La petite enfance est l'âge le plus critique et celui où les investissements sont les plus rentables à long terme. Or, **58,1% des enfants de 0 à 4 ans subissent de multiples privations**¹⁵, près de 80/1 000 enfants meurent avant leur 5ème année, et près de 28/1 000 meurent dès le premier mois. Les principales causes de décès chez les moins de 5 ans sont les causes néonatales (30,8%), le paludisme (13,7%), la pneumonie (12,8%) et la diarrhée (9,3%), les trois principales maladies tueuses des enfants.

La malnutrition demeure une cause sous-jacente importante, car selon le rapport de suivi des 100 indicateurs clés de la santé, le pourcentage des enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance est passé de 28% en 2011 à 28,9 en 2018, alors que la cible des ODD est de mettre fin à toutes formes de malnutrition d'ici à 2030. Les enfants continuent de mourir de causes évitables en particulier dans les zones rurales, chez les populations moins nanties et dans certaines régions du pays.

Les 1 000 premiers jours de la vie

Les 1 000 premiers jours de la vie d'un individu, allant de la conception intra-utérine jusqu'à l'âge de deux ans, représentent la période la plus critique pour

influencer à long terme sa santé physique, son développement psychomoteur et cognitif, et ses capacités d'apprentissage. En effet, **le cerveau se développe à un rythme extrêmement rapide, atteignant 80 % de sa taille totale à l'âge de 3 ans**. Cette croissance cruciale nécessite un environnement bienveillant, garantissant une bonne nutrition, des soins de santé de qualité pour la mère et l'enfant, une stimulation précoce, une attention adéquate et une protection contre les abus. La malnutrition, les infections et le manque de soins peuvent gravement freiner le développement cérébral, entraînant des dommages irréversibles tels que des retards cognitifs ou des malformations congénitales. Ces préjudices peuvent impacter toute la trajectoire de vie de l'enfant, se traduisant par un faible rendement scolaire, des capacités d'apprentissage réduites et un revenu moindre à l'âge adulte.

Durant cette période, **les enfants rencontrent des défis vitaux immenses dès les premières heures et années de leur vie**. Environ 2 millions d'enfants en 2025, se trouvent dans cette catégorie des 0-2 ans (7%). Au Cameroun, seulement 69% des naissances sont assistées par du personnel qualifié et seulement 65% des mères enceintes réalisent les 4 consultations prénatales recommandées¹⁶.

La mortalité maternelle a diminué de près de 50% depuis 10 ans mais reste à 406 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. En moyenne 40% des femmes souffrent d'anémie. Les indicateurs de l'alimentation du nourrisson et du Jeune enfant sont suboptimaux. Respectivement, la mise au sein immédiatement après la naissance est à 40% et l'allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois est de 39%. Seulement, 20% des enfants âgés de 6 à 23 mois bénéficient d'un régime alimentaire (*first food*) diversifié et nutritif (EDS, 2018). La stimulation des bébés reste très faible.

Exister officiellement dès la naissance

Seulement 62% des jeunes enfants de moins de cinq ans ont été déclarés à leur naissance¹⁷. Le droit à une identité légale est le passeport pour bénéficier de programme de protection, pouvoir certifier son parcours scolaire, et devenir un

¹⁵ MODA 2017

¹⁶ EDS 2018

¹⁷ EDS 2018

citoyen à part entière. la loi demande la déclaration de naissance dans un délai de 90 jours. Ce taux est à mettre en regard de la couverture vaccinale en DTC3 qui est à 84,5%, qui prouve que l'on peut atteindre davantage d'enfants pour leur offrir un passeport pour la vie. Dès le départ, **1 enfant sur 3 ne peut pas faire valoir ses droits**. Malgré des avancées significatives en 2024 en termes d'interopérabilité entre les services de santé et l'état civil et la création de 176 postes dans les centres de santé, le service n'est pas encore suffisamment proche des usagers.

Du bébé de 2 ans à l'enfant de 5 ans

Entre 2 et 5 ans, les défis pour l'enfant changent. L'allaitement maternel est souvent arrêté vers l'âge de 2 ans et une alimentation complète et diversifiée devient encore plus importante.

Lors de leur développement, les enfants sont privés d'une nutrition adéquate : alors que **près de 29%18 des enfants souffrent de retard de croissance au niveau national**, ce sont jusqu'à 40 % des enfants dans la région du Nord et 40 % des enfants du quintile le plus pauvre¹⁹. 1,6% souffrent de malnutrition aiguë sévère. La principale cause réside dans les conséquences à long terme du faible taux d'allaitement précoce, ainsi que dans la diversification alimentaire insuffisante du fait du manque de ressources financières des foyers et du manque de connaissances sur les régimes appropriés. Cette sous-nutrition est également le résultat des maladies, comme les IRA, les diarrhées et le paludisme qui affectent le statut nutritionnel des enfants.

A cela s'ajoute le manque d'accès à l'eau qui rend les pratiques d'alimentation et d'hygiène difficiles affectant la santé des plus vulnérables. Bien que 83% des Camerounais disposent d'un accès à des sources améliorées d'eau potable. Ce taux baisse à 75% pour les ménages pauvres ou ruraux. Le niveau d'accès à l'assainissement n'améliore pas la situation car seulement 18% des ménages ruraux disposent de solutions améliorées (avec des sources d'eau sécurisées).

La vaccination pourrait contrecarrer les effets des conditions précaires de salubrité, mais la couverture DCT3 n'est pas optimale avec 84,5% (2024) et reste en deçà du niveau de 2013 (89%)²⁰. La période de la COVID-19 et la campagne de vaccination liée ont accentué les hésitations à la vaccination, surtout dans les zones urbaines. Depuis, les taux sont remontés mais des efforts importants sont à mener pour retrouver des niveaux acceptables, notamment dans certaines zones péri-urbaines. Fin 2024, le pays comptait 139 586 enfants non vaccinés au Penta 1, identifiés comme étant des "zéro dose", soit 13,6% d'enfants cibles.

Chaque année 336 000 enfants meurent avant leur 5^{ème} anniversaire

L'analyse de l'évolution des enfants zéro dose montre une diminution progressive dans les régions de l'Adamaoua (2%), le Sud (3%), l'Est (5%), le Nord (8%), l'Ouest (10%) entre 2022 et 2024. Les régions de l'Extrême Nord (22%) du Nord-Ouest (13%) et du Sud-Ouest (12%), elles, présentent une augmentation chronique du nombre d'enfants zéro dose de 2022 à 2024.

Près d'un quart des enfants souffrent du paludisme. Ce taux a diminué notamment grâce à l'utilisation de moustiquaire imprégnée dont le taux a fortement augmenté sur la dernière décennie pour atteindre 41% en 2019²¹ et à l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination de routine. Le PEV s'était fixé comme objectif de vacciner en fin 2024, au moins 50 % des 249 133 enfants âgés de six mois dans les 42 premiers districts ayant introduit le vaccin antipaludique. À la fin de l'année 2024, les données du PEV ont montré des taux de couverture dépassant les attentes : 69,4 % pour la première dose, 55,9 % pour la deuxième dose et 53,8 % pour la troisième dose.

¹⁸ EDS 2018

¹⁹ MICS 2014

²⁰ Gavi note

²¹ INS et al., 2019



Le temps de l'école et de l'apprentissage des compétences



Le Cameroun compte 5,6 millions d'enfants de 6 à 14 ans. Même si les enfants ont pu dépasser les défis des premières années, **48,6% des 5 à 11 ans subissent encore de multiples privations dans cette tranche d'âge**²². Près de 14% d'entre eux ne vont pas à l'école (contre 90,1 % des enfants scolarisés en Primaire), le plus souvent pour un travail ou un mariage précoce parce que les parents manquent des ressources financières nécessaires. L'accès au préscolaire à l'âge de 5 ans est assez faible au Cameroun (41%²³) et révèle une fracture importante entre le milieu urbain et le milieu rural.

Dans certaines régions (Nord), 35% des enfants ne suivent aucun apprentissage²⁴. L'école peut également être un lieu difficile pour l'enfant, où

près de 28,75% des filles et 41,7% des garçons ont subi des violences physiques. De plus, **69% des écoles n'ont pas d'accès à l'eau potable, et 59% n'ont pas de latrines adéquates**. Ces défauts d'infrastructures ne participent pas au maintien des bonnes pratiques d'hygiène et peuvent même porter préjudice aux jeunes filles, notamment des périodes d'absentéisme pendant les menstruations.

Le travail des enfants augmente, les privant d'école. Le taux de transition du primaire au secondaire à l'âge de 12 ans est de 60,96% pour les garçons et de 59,56% pour les filles²⁵.

Zoom sur le Sud-Ouest et Nord-Ouest : En raison de la crise actuelle, où l'éducation est sous attaque par les groupes armés non-étatiques, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest vivent une situation catastrophique en termes d'éducation : certains enfants ne vont plus à l'école depuis plus de 5 ans (le taux de scolarisation est tombé à 37% en 2018)²⁶. **Cette partie du pays est en train d'hypothéquer une génération entière**, enterrant les chances de relèvement pour les prochaines décennies. Le coût futur de la perte d'éducation est estimé à 4 milliards de dollars²⁷. De nombreux enfants de cet âge sont engagés dans des conflits, dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Les services sociaux manquent de ressources pour accompagner ces enfants : **on compte seulement 1 travailleur social pour 278 enfants orphelins ou vulnérables contre 1 pour 15 recommandé**²⁸.

²² MODA 2014

²³ Annuaire Statistique du MINEDUB et son Rapport d'analyse (publiés en février 2025)

²⁴ MICS 2014

²⁵ Annuaire statistique du ministère de l'Enseignement secondaire, 2023

²⁶ The Socio-Political Crisis in the Northwest and Southwest Regions of Cameroon: Assessing the Economic and Social Impacts, World Bank 2021

²⁷ Ibid

²⁸ World Bank 2021



Le temps de l'adolescence : Protection des enfants contre la violence



1,7 millions d'enfants sont âgés de 15 à 17 ans au Cameroun. Pour ceux qui ne vont pas à l'école, le quotidien est rythmé par le travail. Ainsi, 47% des enfants de 5 à 17 ans ont travaillé et 40% sont engagés dans un travail dommageable pour leur santé et leur développement²⁹, et pour les filles qui ne vont pas à l'école, la pire des alternatives est souvent le mariage : près de 10% des filles de moins de 15 ans sont mariées, et 24% des filles (15-19 ans³⁰) ont commencé leur vie reproductive, empêchant toute autonomisation future et entraînant des problèmes de santé. Les enfants issus de ces grossesses précoces démarrent

leur vie dans une situation de pauvreté et vulnérabilité accrue, et demeurent les plus touchés par les carences nutritives et les problèmes de santé.

Les violences sexuelles sont également largement répandues : 7,7% des filles et 2,9% des garçons en sont victimes entre 15 et 19 ans³¹.

La santé sexuelle et reproductive est un enjeu pour ces générations, la prévalence du VIH est de 1,3% mais la connaissance profonde des modes de transmission du VIH est seulement de 41%³² pour les jeunes femmes. Il faut noter que seules 15% des femmes entre 15 et 49 ans³³ pratiquent la contraception sous forme moderne, perpétuant le rythme des naissances rapprochées.

Seules 59% des filles sont scolarisées au secondaire



²⁹ World Bank EdStats 2019

³⁰ EDS 2018

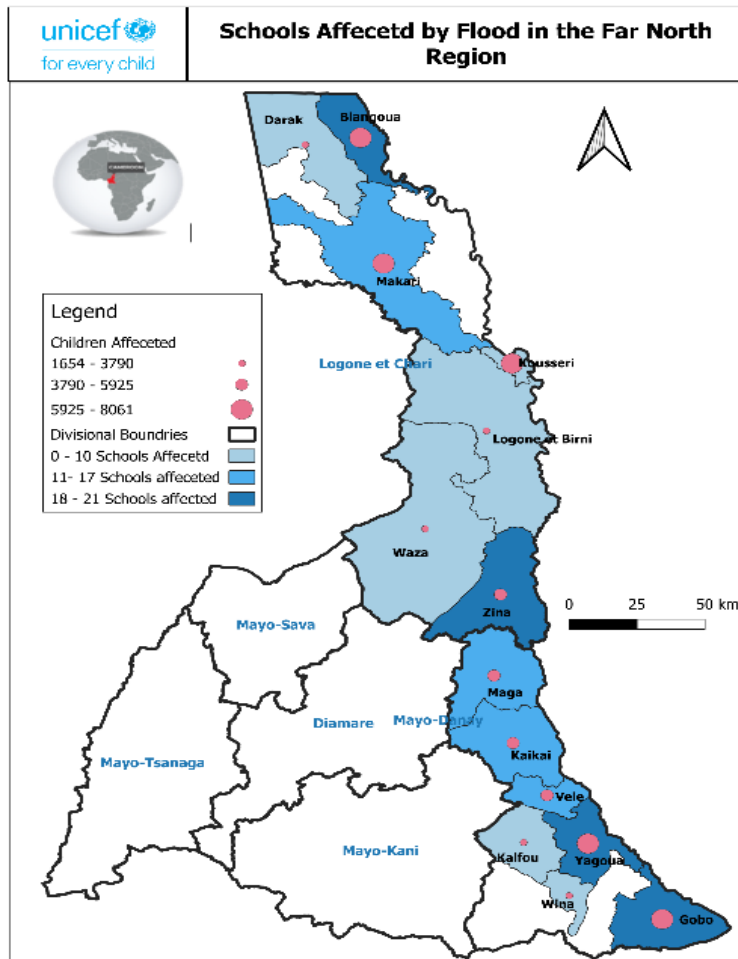
³¹ EDCC

³² EDS 2018

³³ EDS 2018



La vulnérabilité des enfants face au changement climatique



Selon l'Indice de risque climatique pour les enfants de l'UNICEF (CCRI), le Cameroun est classé 10^{ème} parmi les trente pays au monde où les enfants sont les plus exposés aux dangers climatiques et environnementaux, aux chocs et aux stress³⁴. Le pays rassemble sur son territoire de nombreux climats et écosystèmes de l'Afrique tropicale, avec ses territoires dans les zones sahéliennes sévèrement touchés par la sécheresse et la désertification, ses territoires dans les zones côtières menacés par l'accélération de l'érosion côtière et la montée des eaux, et ses territoires dans le bassin du Congo affectés par la déforestation et la diminution de la biodiversité.

Les catastrophes induites par le changement climatique comprennent les sécheresses et vagues de chaleur, les fortes pluies et les inondations, les glissements de terrain et coulées de boue, les feux de brousse, la poussière, les orages et les tempêtes de vent, ainsi que la montée du niveau des eaux. Ces dernières années, le Cameroun a connu une augmentation significative de la fréquence, de la gravité et de l'impact de ces catastrophes. Ces événements dévastateurs ont entraîné des pertes en vies humaines d'une part et socio-économiques substantielles d'autre part, affectant ainsi le bien-être de milliers de personnes à travers le pays, en particulier les enfants. Le Gouvernement camerounais estime qu'en moyenne, 3 millions de personnes sont affectées (soit une personne sur 10), selon les projections du BUCREP³⁵. Le changement climatique a un impact direct sur plus de 70 pour cent de la population dont les moyens de subsistance dépendent directement de l'agriculture³⁶. Les inondations ont souvent entraîné la destruction de maisons, de champs, d'écoles, d'établissements de santé et d'infrastructures, privant les enfants d'éducation, d'abris, de soins de santé de qualité et de nourriture.

Zoom sur l'impact du changement climatique dans la région sahélienne du pays (Extrême-Nord et Nord) - Les régions septentrionales du pays sont les plus marquées par le changement climatique qui impacte l'éducation, la protection, l'alimentation de qualité, l'accès à l'eau et l'accès aux services sociaux de base pour les enfants. Dans ces régions, de fortes pluies alternent avec une saison

³⁴ Les dix pays ayant l'indice de risque climatique pour les enfants le plus élevé sont la République centrafricaine (1), le Tchad (2), le Nigeria (2), la Guinée (4), la Guinée-Bissau (4), la Somalie (4), le Niger (7), le Soudan du Sud (7), la République démocratique du Congo (9), l'Angola (10), le Cameroun (10), Madagascar (10) et le Mozambique (10). [The climate crisis is a child rights crisis. Introducing the children's climate risk index](#). UNICEF, 2021.

³⁵ Gouvernement du Cameroun, Elaboration des Plan Régionaux de Développement, 2021. En comparaison, le Plan national d'adaptation au changement climatique de 2015 estimait que 320 000 personnes étaient affectées chaque année.

³⁶ Les Rapports nationaux sur le climat et le développement du Groupe de la Banque Mondiale, 2022

sèche de six à sept mois, d'octobre à avril, entraînant des inondations et des sécheresses sporadiques mais significatives. La température maximale quotidienne moyenne de 36 degrés Celsius peut grimper jusqu'à 47° en saison chaude (source ONACC). Dans l'Extrême-Nord, les pluies abondantes et les inondations récurrentes ont souvent entraîné des décès, les déplacements des populations vers des sites temporaires, la limitation d'accès aux structures d'éducation, hospitaliers et sociaux, l'inondation des points d'eau et des latrines, des aires de loisirs et espaces verts ³⁷. Les nouvelles conditions environnementales sont plus propices aux moustiques et à la propagation du paludisme, les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans étant les plus à risque. Les moyens de subsistance locaux dépendent fortement des ressources naturelles déjà dégradées ; les catastrophes induites par le climat et les infestations récurrentes de criquets contribuent à des taux inquiétants d'insécurité alimentaire.

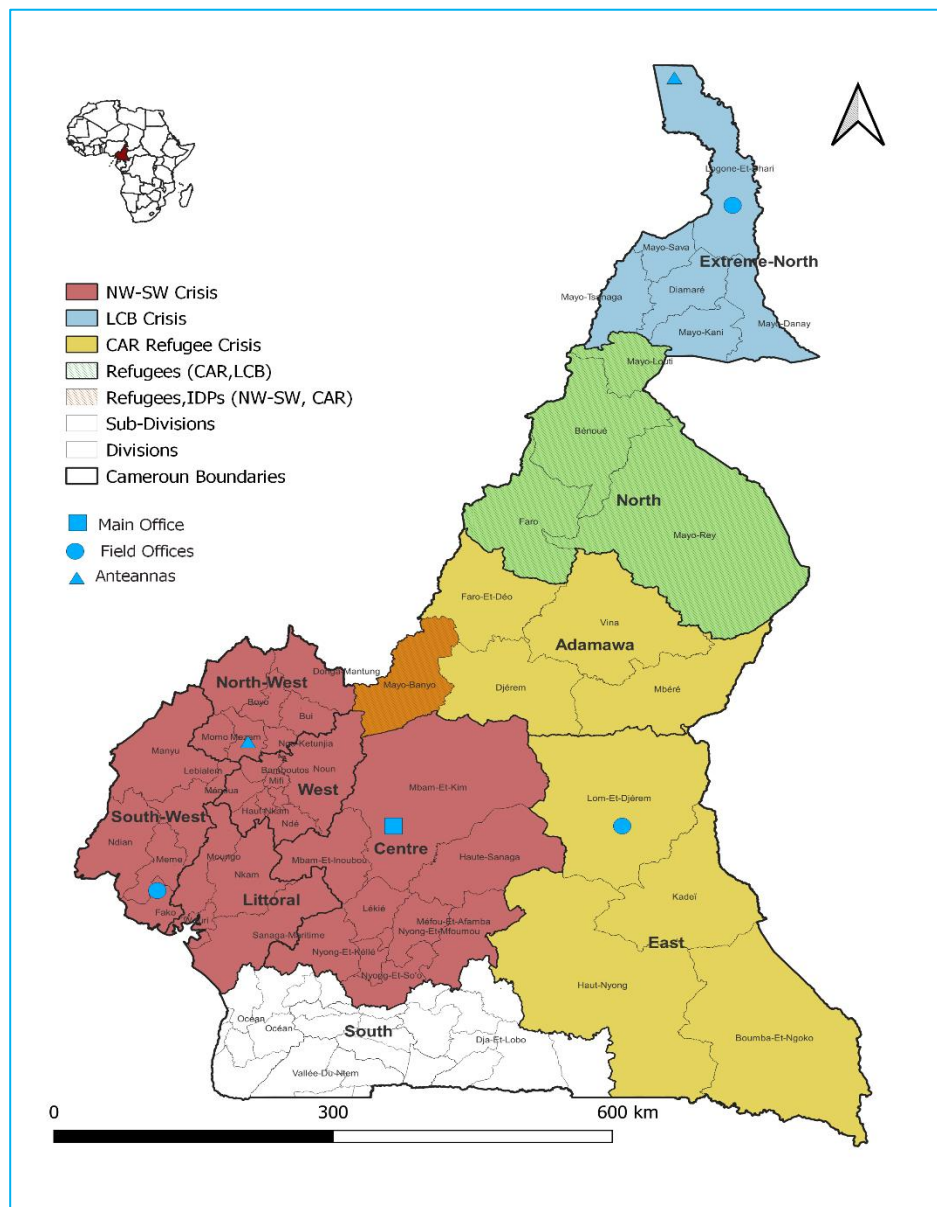


³⁷ Par exemple, des inondations exceptionnelles ont affecté près de 460 000 personnes dans l'Extrême-Nord en 2024, endommagé ou détruit 56 084 maisons, 262 écoles et 65 centres de santé. Plus de 85 000 hectares de terres agricoles ont été inondés, perturbant une saison agricole déjà fragile. En 2022, des inondations ont affecté plus de 313 000 personnes dans

l'Extrême-Nord, causant au moins 23 décès et déplaçant plus de 113 000 personnes. On estime que 31 000 maisons, 48 000 hectares de champs et 6 700 animaux ont été détruits ou endommagés, 151 écoles primaires et secondaires ont été inondées, et plus de 200 points d'eau et 2 620 latrines ont été submergés. Une douzaine d'établissements de santé ont été complètement inondés et rendus non opérationnels.



Vulnérabilités Régionales



Instability-The-2024-Review-of-the-Peace-and-Security-Council.pdf

Les inégalités régionales au Cameroun sont particulièrement marquées, avec certaines zones cumulant les plus faibles indicateurs de bien-être de l'enfant. La pauvreté infantile atteint des niveaux supérieurs à la moyenne nationale de 47,5% dans les régions suivantes : 74,1 % des enfants dans le Nord-Ouest, 73,9 % dans l'Extrême-Nord et 65,6 % dans le Nord vivent en situation de pauvreté monétaire. Les privations multidimensionnelles affectent également plus de 50 % des enfants dans l'Est (50,3 %) et l'Adamaoua (43,2). Ces régions sont aussi les plus exposées aux crises humanitaires, aux déplacements massifs de population, aux chocs climatiques et à l'insuffisance des services sociaux de base. L'accès à l'eau potable, à la vaccination, à l'éducation et à l'enregistrement des naissances y est souvent bien inférieur à la moyenne nationale.

Extrême-Nord

La région de l'Extrême-Nord est la plus densément peuplée du Cameroun, avec 5 623 776 habitants. Avec 69,2 % des ménages vivant sous le seuil de pauvreté et près de 74 % des enfants en situation de pauvreté monétaire, elle présente certains des pires indicateurs de bien-être de l'enfant du pays.

La région est confrontée à une situation complexe, marquée par des conflits, des chocs climatiques et des épidémies. Des incursions violentes de groupes armés non étatiques (GANE) provoquent des pertes civiles, des enlèvements et des destructions de biens. En 2024, le nombre d'incidents violents a fortement augmenté, faisant du Cameroun le pays ayant enregistré le plus grand nombre de décès liés aux conflits, dépassant pour la première fois le Nigeria³⁹. Les violences et les catastrophes naturelles, notamment les inondations, ont entraîné le déplacement interne de plus de 454 000 personnes dans la région³⁹. En plus des personnes déplacées à l'intérieur du pays, la région accueille

³⁹ DTM, IOM, August 2024.

également plus de 122 000 réfugiés fuyant la crise du bassin du lac Tchad au Nigeria voisin⁴⁰.

Les enfants sont particulièrement vulnérables dans ce contexte. **Seulement 24 % des enfants âgés de 12 à 24 mois sont complètement vaccinés**, contre une moyenne nationale de 82,5 %. Les infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) sont endommagées ou insuffisantes, privant de nombreuses communautés d'un accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat. De nombreux enfants sont séparés de leur famille, rencontrent des obstacles à l'éducation et sont exposés au risque de recrutement par des groupes armés. **Le taux de scolarisation reste extrêmement faible**, et l'accès aux services de santé, de nutrition et de protection est gravement limité. L'enregistrement des naissances constitue également un enjeu majeur, en particulier pour les populations déplacées, ce qui accroît les risques d'exposition aux violences et abus et limite l'accès aux services essentiels.

Nord

La région du Nord du Cameroun est confrontée à des défis persistants pour son développement, exacerbés par les chocs climatiques et les niveaux élevés de pauvreté infantile. **Avec 61,1 % des ménages vivant sous le seuil de pauvreté et 65,6 % des enfants touchés par la pauvreté monétaire, la région est l'une des plus défavorisées du pays.** Les enfants sont particulièrement vulnérables à la malnutrition et aux problèmes de santé : 40 % des enfants de moins de cinq ans souffrent d'un retard de croissance et seuls 25 % des enfants âgés de 12 à 24 mois sont complètement vaccinés. **L'accès à l'éducation est également limité : 35 % des enfants ne bénéficient d'aucune forme d'apprentissage et de nombreuses écoles ne disposent pas d'infrastructures sanitaires de base.**

Nord-Ouest et Sud-Ouest

Depuis 2017, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun ont été englouties dans une crise sociopolitique prolongée, entraînant une violence généralisée, des déplacements et des besoins humanitaires. En 2024, 334 000 personnes sont déplacées dans ces régions dont près de 100 000 enfants⁴¹, 74 000 ont cherché refuge au Nigéria⁴². On compte 43 605 enfants non accompagnés ou séparés (UASC) exposés à la violence, aux abus et à la détresse psychosociale⁴³. La crise a gravement perturbé l'éducation - **41 % des écoles ne sont pas opérationnelles, ce qui fait que 223 749 enfants ne sont pas scolarisés et que le risque de recrutement dans des groupes armés non étatiques augmente.**

L'accès aux services de base s'est fortement détérioré. Les attaques contre les infrastructures de santé et d'éducation, combinées à l'insécurité, ont fait chuter la couverture vaccinale à 64,5 %, contre une moyenne nationale à plus de 82 %. **Les installations sanitaires ont été endommagées ou détruites, laissant de nombreuses communautés sans eau potable ni assainissement adéquat.** Ces conditions ont augmenté le risque de maladies d'origine hydrique et de malnutrition aiguë, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes. **L'absence d'enregistrement des naissances aggrave encore les risques de protection des enfants**, en compromettant leur accès aux services essentiels et à l'identité légale.

Avant la crise, les régions du nord-ouest et du sud-ouest représentaient une part substantielle de l'économie formelle du Cameroun, des exportations agricoles et de l'emploi. Les régions anglophones possédaient également l'un des niveaux les plus élevés de capital humain au Cameroun avant la crise et bénéficiaient d'un bon accès à une éducation de qualité. **La crise a augmenté les niveaux de pauvreté et endommagé les moyens de subsistance et le capital humain.** Les effets combinés de la baisse des revenus (due à la réduction de l'emploi) et de la hausse des prix à la consommation (due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement) ont lourdement pesé sur le bien-être des ménages. **Le**

⁴⁰ DTM, IOM, August 2024.

⁴¹ DTM, IOM, September 202

⁴² Source, UNHCR May 2025.

⁴³ MSNA, IOM, OCHA, September 2024

taux de pauvreté infantile dans le Nord-Ouest s'élève à 74,1 %, soit le taux le plus élevé du pays.

Est et Adamawa

Les régions de l'Est et de l'Adamawa au Cameroun sont marquées par une **grande pauvreté, des indicateurs sociaux faibles et la présence à long terme de réfugiés de la République centrafricaine (RCA)**. En mai 2025, ces deux régions accueilleraient plus de 222 000 réfugiés, ce qui exerce une pression considérable sur les services et infrastructures locaux déjà fragiles.

Les enfants de ces régions sont particulièrement vulnérables. La pauvreté multidimensionnelle des enfants touche 50,3 % des enfants dans l'Est ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 47,5 %.

Les taux d'enregistrement des naissances sont parmi les plus bas du pays : 42 % dans l'Est et 53 % dans l'Adamawa, alors que la moyenne nationale est de 62 %. Le mariage des enfants reste une préoccupation majeure, en particulier dans l'est du pays, et le travail des enfants dans les activités minières les expose à de graves risques en matière de santé, de protection et d'éducation.

La région de l'Est a le deuxième taux de mortalité infantile le plus élevé du pays, avec 122 décès pour 1 000 naissances vivantes, tandis que l'Adamawa se classe au quatrième rang avec 96 décès pour 1 000. L'accès à l'eau potable est inférieur à la moyenne nationale (74 %), avec seulement 60 % dans l'Adamawa et 68 % dans l'Est. La couverture sanitaire est également faible, en particulier dans les zones rurales.

La malnutrition chronique touche 37 % des enfants dans l'Est et 35 % dans l'Adamawa, ce qui place ces deux régions parmi les quatre les plus touchées du pays. La couverture vaccinale est également inférieure aux niveaux nationaux, avec seulement 72% des enfants âgés de 12 à 23 mois complètement vaccinés dans l'Adamawa, contre 27% dans l'Est. **Le taux brut de scolarisation préscolaire est de 48,7 % dans l'Est et de seulement 18,6 % dans l'Adamawa**, tandis que le taux d'achèvement des études primaires est de 80,5 % dans l'Est et de 75,5 % dans l'Adamawa. Les deux régions sont classées zones d'éducation prioritaire,

ce qui reflète l'urgence d'investir dans les infrastructures et les services éducatifs.

Géographiquement, les régions de l'Est et de l'Adamawa sont vastes et difficiles d'accès. Le mauvais état des routes et les longues entravent la prestation de services. Ces défis logistiques, combinés à une présence limitée de l'État dans les zones reculées, exacerbent la vulnérabilité des enfants et des familles.



UNICEF CAMEROON

Nadine Perrault - Country Representative
nperrault@unicef.org / +237 222 223 182

Juliette Haenni - Deputy Representative Programme
jhaenni@unicef.org / +237 697 412 221 +237 656 249 385 / +237 222 223 182

Anne Fouchard - Chief Partnerships, Advocacy and Communication
afouchard@unicef.org / +237 657 750 532 / +237 222 223 182